COMPRENDRE VOTRE TRAITEMENT · FICHE N° 12

Freiner la myopie chez l'enfant

La photobiomodulation utilise une lumière douce, rouge ou infrarouge, qui ne chauffe pas et ne brûle pas, pour aider les cellules à se réparer et à calmer l'inflammation et la douleur.

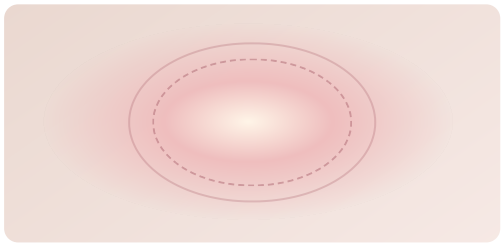
La myopie de l'enfant



- **La myopie de l'enfant s'aggrave souvent pendant la croissance.**
- **Regarder une lumière rouge douce 3 minutes, 2 fois par jour, à la maison.**
- **Les études montrent un net ralentissement, mais la sécurité de la rétine doit être surveillée.**

01 / COMPRENDRE

Comment ça marche ?



LA LUMIÈRE UTILISÉE

La fiche décrit un dispositif de lumière rouge prescrit et utilisé avec un suivi ophtalmologique.

02 / EN PRATIQUE

Comment se passe une séance ?

DURÉE
3 minutes

LIEU
À la maison, avec un appareil prescrit

SENSATION
Une lumière rouge vive, avec parfois une image rémanente brève

PROFESSIONNEL
L'enfant, sous la surveillance d'un adulte

Le rythme habituel

2 séances de 3 minutes par jour (au moins 4 heures d'écart), 5 jours sur 7, pendant plusieurs mois.

Le ralentissement de la myopie se voit dès quelques mois. À l'arrêt, la myopie peut reprendre : l'arrêt doit être progressif et décidé avec l'ophtalmologiste.

03 / SCIENCE

Ce que disent les études

SYNTHÈSE DE LUMINATHÈQUE

Niveau de preuve · Prometteuse

52 / 58

études analysées sur le site concluent en faveur de la photobiomodulation pour les catégories associées à cette fiche.

Les résultats sont encourageants mais doivent encore être confirmés par de grands essais. Le nombre d'études favorables ne mesure pas à lui seul l'efficacité clinique.

04 / SÉCURITÉ

Est-ce sans danger ?

- Uniquement avec un appareil prescrit et un suivi ophtalmologique (fond d'œil, OCT).
- Arrêtez et consultez si l'image rémanente dure plus de quelques minutes ou si la vision baisse.
- Ne jamais utiliser une autre lumière ou un laser non prévu pour cet usage.
- La séance ne doit jamais viser directement les yeux, sauf appareil ophtalmologique prévu pour cela.

05 / VOS QUESTIONS

Les réponses essentielles

Est-ce mieux que les lunettes spéciales ou l'atropine ?

Les études la placent parmi les options efficaces ; elle peut s'y associer.

Est-ce sans risque ?

Aucune lésion grave n'a été démontrée, mais le recul est limité : la surveillance est indispensable.

Références scientifiques

- Lumière rouge basse intensité répétée contre la myopie de l'enfant : essai multicentrique
  Ophthalmology · 2021 · PMID 34863776
- Sécurité de la lumière rouge répétée dans la myopie : revue systématique
  Asia Pac J Ophthalmol (Phila) · 2024 · PMID 39672511
- Lumière rouge chez l'enfant pré-myope : résultats à deux ans et rebond
  Br J Ophthalmol · 2025 · PMID 41072941

Fiche d'information générale réalisée à partir de la littérature scientifique (Luminathèque, 9 nov. 2026). Elle ne remplace pas l'avis de votre médecin ou de votre soignant. Illustration à visée pédagogique.